

治験届作成に関する概要

治験届とは【What】

治験届は新薬の治験開始前に提出する届出文書で承認ではなく受理

01

治験届の定義

治験届とは、新薬臨床試験開始前に製薬会社が厚生労働大臣に提出する届出文書のことです。

02

薬機法の基づく制度

薬機法第80条の2に基づき、この届出は審査を経ずに治験が自動開始可能となっています。

03

治験開始

治験届提出後、30日間の調査期間で照会事項へ回答を完了して治験開始が可能となる。実質、21日での対応が必要。

提出タイミング【When】

治験開始を確実にするため、適切なタイミングでの計画が重要

30日調査対象

治験届は治験開始予定日の少なくとも30日前に提出する必要があります。このタイミングを順守して、治験開始までに必要な全ての手続きを確実に行う必要がある。

14日調査対象

同一薬剤の2回目以降の治験では、より短い14日ルールが適用されます。該当する項目を見極めて計画変更届の作成、提出および紹介回答が必要となる。

正式にはガイドラインでは14日ルールという文言は存在せず、30日調査およびそれ以外の項目が記載されています。

薬生薬審発0831第10号
令和2年8月31日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
（ 公 印 省 略 ）

治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の
届出等に関する取扱いについて

標記については、「薬事法等の一部を改正する法律の施行について」（平成9年3月27日付け薬発第421号厚生省薬務局長通知。以下「局長通知」という。）、
「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する
取扱いについて」（平成25年5月31日付け薬食審査発0531第8号厚生労働省
医薬食品局審査管理課長通知。以下「課長通知」という。）等により取り扱って
きたところです。

今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和2年
厚生労働省令第155号）の施行に伴い、治験の計画の届出についてその取扱い
の一部を下記のとおり改めましたので、貴管下関係業者等に対して周知いた
きますよう御配慮願います。

なお、本通知の適用に伴い、課長通知は、令和4年8月31日限り廃止します。

<https://www.pmda.go.jp/files/000236408.pdf>

る治験についてマイクロドーズ臨床試験以降初めて届け出る治験の計
画が30日調査の対象となること。

ウ 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売承認（外国製
造販売承認等を含む。）を与えられている医薬品（以下「既承認医薬品
等」という。）と有効成分及び投与経路が同一であるが、例えばナノ技
術を応用すること等で徐放化等の薬剤学的な変更により用法等を異に
することを目的とした新たな剤形の薬物のうち、有効成分を内包する
等の製剤設計により有効成分の体内分布や標的部位への移行性が大き
く異なると想定される薬物を用いた治験を届け出る場合には、上記ア
と同様に治験の計画を届け出ること。

エ 上記ア～ウ以外の治験計画届書については、実施医療機関との予定契
約締結日の少なくとも2週間程度前を目安として届け出ること。た
だし、当該届出に係る治験の計画が第Ⅰ相試験等に該当する場合におい
ては、その届出時期についてあらかじめPMDAに相談することが望
ましい。

② 治験計画変更届書

ア 治験計画届書に変更が生じる場合に、原則として、治験計画届書ごと
に変更の前に届け出ること。

イ 届書に30日調査対象の被験薬を追加する場合は、当該被験薬を追加
した治験実施計画書で治験を実施する30日以上前に届け出ること。

ウ 30日調査対象外の被験薬を追加する場合又は本邦において安全性情
報が十分に蓄積されていない治験使用薬（被験薬を除く。）を追加する
場合は、当該被験薬又は当該治験使用薬（被験薬を除く。）を追加した
治験実施計画書で治験を実施する2週間程度前に届け出ること。また、
目的又は対象疾患を変更する場合、目的又は対象疾患を変更した治験
実施計画書で治験を実施する2週間程度前に届け出ること。

エ 次に掲げる事項については、変更後6か月（ただし、治験分担医師の
氏名の変更並びに追加及び削除のみの変更については1年）を目安と
してまとめて届け出ることと差し支えないこと。また、治験使用薬の予
定交付（入手）数量及び予定被験者数は、治験の実施に伴って生じた数
量及び被験者数の変更については届け出る必要はなく、治験終了届書
又は治験中止届書にてまとめて届け出ることと差し支えない。

また、最後の治験計画変更届書を届け出た後6か月（ただし、治験
分担医師の氏名の変更並びに追加及び削除の変更については1年）が
経過する前に治験終了届書又は治験中止届書を届け出る場合、それま
でに発生した変更事項については、治験終了届書又は治験中止届書中

提出タイミング【When】

軽微変更としてまとめて届け出可能な事項一覧（6か月または1年以内） 一部抜粋

基本ルール

- 原則：6か月以内にまとめて届け出
- 例外：治験分担医師の氏名の変更・追加・削除は1年以内に届け出
- ※治験終了届書・治験中止届書提出時に未届の内容を同時に届け出することも可

組織・施設・業者の変更場合

- 実態の変更を伴わない製造所・営業所の名称・所在地・業者コードの変更
- 治験届出者の法人名・代表者・住所・業者コードの変更（実態変更なしに限る）
- CRO（開発業務受託機関）の氏名・住所・業務範囲の変更、追加・削除
- SMO（治験施設支援機関）の氏名・住所・業務範囲の変更、追加・削除

医師の変更の場合

- 治験責任医師の氏名の変更
- 実施医療機関削除に伴う治験責任医師の削除
- 治験分担医師の氏名の変更・追加・削除（※1年以内）
- 治験調整医師・治験調整委員会構成医師の削除

誰が関与するか【Who】

治験届作成には複数の部門が関わり情報共有が不可欠です。

製薬会社とCRO

製薬会社は治験全体の管理責任を持ち、CROは文書作成や翻訳などを補助し運用を支援します。

CRAとメディカルライター

CRAはプロトコルの整備や医療機関との調整、メディカルライターはIBやICFの作成を担います。

薬事部門と開発責任者

薬事部門は届出作成とPMDA提出を担当し、開発責任者は最終承認を行います。

プロセスフロー【How】

治験届作成は、計画段階からPMDAへの提出、IRB承認、そして治験開始までのステップを慎重に進めることが成功への鍵です。



計画と意思決定

治験の最初のステップは、開発戦略の策定とPMDAとの事前相談を基にした意思決定です。この段階では、治験の全体構想を明確にし、実行可能性を確認します。



文書作成とレビュー

治験プロトコル、IB、ICFなどの重要文書をドラフトし、社内および外部のレビューを経て内容を精査し承認します。これが全体の進行を左右する重要な段階です。

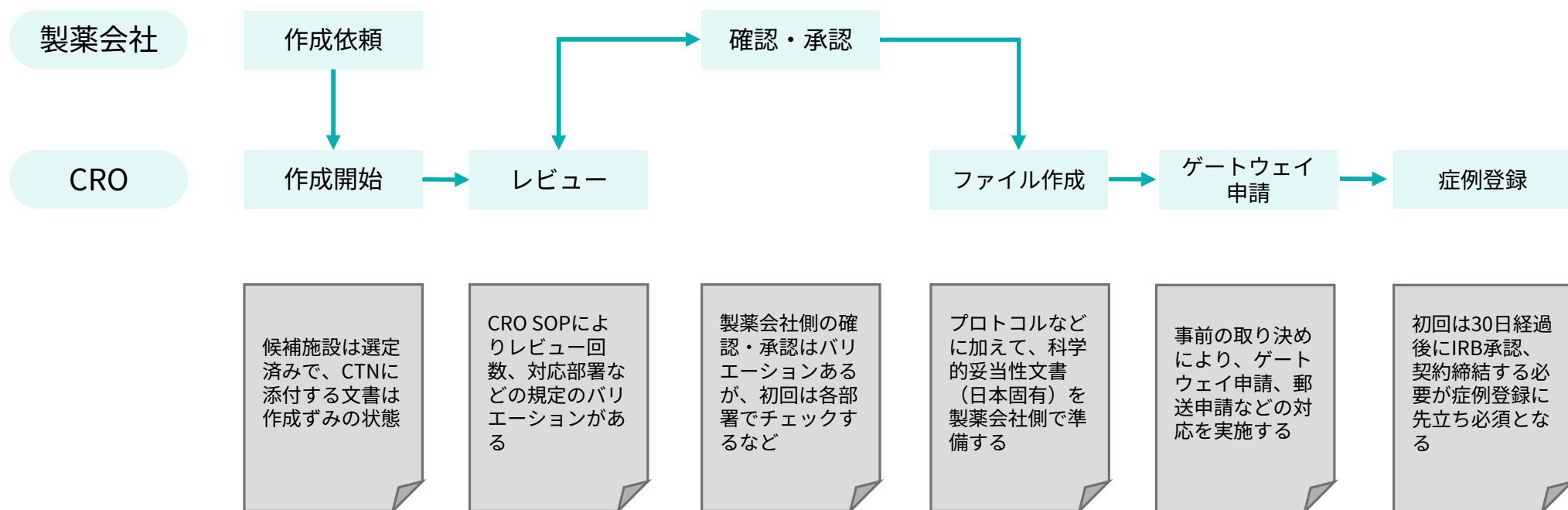


PMDA提出と治験開始

必要な文書が整った後、治験計画届をPMDAに提出し、IRB承認を取得します。その後、治験施設での治験開始準備を行い、初月組入れを実施します。

ステップ	What（内容）	Who（担当）	Where（実施場所）	When（タイミング）	How（方法）
① 治験構想と意思決定	社内開発戦略・PMDA事前相談の検討	製薬会社開発チーム	社内	治験開始6～12か月前	会議、PMDA事前相談
② 文書ドラフト作成	プロトコル、IB、ICF、CRF案など	CRO・CRA・MW等	社内・CRO	開始6～4か月前	Word等による作成
③ 社内レビュー	安全性、薬事、QA等のチェック	製薬会社・CRO	社内	開始4～3か月前	メール、SP共有など
④ 文書承認	最終版承認・バージョン管理	製薬会社	社内	開始3か月前	承認ルートによる押印または電子署名
⑤ 届出書（XML/PDF）作成	XML入力・PDF生成・整合性確認	CROまたは薬事	届出支援システム	開始3～2か月前	XMLエディタ、SaaS型システム
⑥ PMDA提出	紙・CD-R/DVD-R提出、受付番号取得	製薬会社薬事部	PMDA	開始2か月前	郵送または持参
⑦ IRB承認・契約締結	各施設のIRB審査と契約	CRA・CRO	各医療機関	提出後30日間	IRB提出・契約手続き
⑧ 初回組入れ	FPI（First Patient In）	医師・CRA	各医療機関	提出から30日＋α後	同意取得・初回投与

プロセスフロー【How】



CROとの協業をモデルとした一例のため各社により独自のプロセスがあります。

治験届の構成

治験届の記載項目

1) 共通事項

2) 主たる被験薬に関する届出事項

3) 治験使用薬、治験使用機器当、
治験使用製品相当

4) 実施医療機関情報

5) 参照する治験届出情報

治験届の種類

治験計画届

治験計画変更届

治験中止届

治験終了届

開発中止届

CTN作成フロー（日本語プロトコル作成後～）

フェーズ	名称	主な入力・トリガー	主担当	システム/ツール	主要アウトプット	チェックポイント
0	事前セットアップ (データ基盤)	Study / Country / Site / PI / IRB/IMP マスタ登録	SSUリード	CTMS	固定情報マスタ（施設・PI・ IRB・CRO・IMP）	施設住所・IRB・医師情報を確認し更 新。過去情報の更新リストアップ。
1	施設選定 (Feasibility / SSV)	プロトコル日本語版、Feasibility質 問票、過去実績	SSU / CRA	CTMS / eTMF	施設評価結果・SSV記録・候補 症例リスト	IRB体制・開催周期・患者プールな ど、選定判断根拠を明確化。
2	責任医師合意 (LOI/ 受諾書)	見積・契約条件・体制案	SSU / 施設事務局 / PI	CTMS / 契約管理トラッ カー	合意書・PI確定・IRB情報更新	医師リスト・所属・IRB情報を確定 し、マスタ更新。
3	CTN起票（初回届出）	プロトコル概要・被験薬・治験実施 体制・添付資料	RA / Ops / SSU	DDW / VeeVa	XML + PDF（治験届出書）	記載必須項目（届出共通事項・予定被 験者数・用法用量等）整合チェック。
4	CTNレビュー（社内）	ワークフロー （メール、SharePoint）	実施体制による（RA一次起 票→QA→メディカル/統 計）	ワークフロー （メール、SharePoint）	修正履歴付き承認済CTNパッ ケージ	XML / PDF版整合、差異理由ログ、最 終承認記録を保存。
5	CTN提出（PMDA提出）	最終承認済XML / 添付資料	RA	PMDAゲートウェイ / CTMS連携	提出ログ・受付番号記録	オンライン提出：1提出=1届出。受付 番号・日付を自動記録。照会ルート確 立。
6	照会対応・変更届処理	PMDA照会票・根拠資料	RA / 関連部門	問い合わせ管理 / eTMF	回答書・差替資料・変更届	照会期限・回答履歴を管理。必要に応 じ変更届／一部変更届へ分岐。

【届出区分の考え方(イメージ表)】

	届出回数	変更回数	変更箇所	届出区分
治験計画届	3			「1」又は「2」(※1)
治験計画変更届	3	1	治験分担医師の追加	「3」
治験計画変更届	3	2	対象疾患の追加	「2」
治験計画変更届	3	3	CROの追加・変更	「3」
治験計画変更届	3	4	被験薬の追加、治験分担医師の追加	「1」又は「2」(※1)
治験計画変更届	3	5	備考欄の追加	「3」
治験計画変更届	3	6	目的の変更	「2」
治験計画変更届	3	7	届出担当者の変更	「3」
治験計画変更届	3	8	治験使用薬(被験薬を除く)の追加	「2」又は「3」(※2)
治験計画変更届	3	9	治験分担医師の削除	「3」
治験終了届	3			「3」

※1: 被験薬が30日調査対象である場合は「1」、被験薬が30日調査対象以外である場合は「2」

※2: 治験使用薬(被験薬を除く)が、本邦において安全性情報が十分に蓄積されていない治験使用薬(被験薬を除く)の場合「2」、それ以外の場合「3」

[R3.6.8 開催 医薬品医療機器等法改正説明会資料]

治験届の構成 - 詳細

届出回数

主たる被験薬と同一治験成分記号に係る治験計画届書（変更届書等は含まない。）の通算の届出回数を入力すること。変更届等に関わらず、同一治験においては変更しない。

変更回数

同一治験における治験届の記載項目に関する変更毎に申請する際の回数により変更する。

届出区分

変更内容により区分を選択する。30日調査対象は「1」、基本通知の（6）の原則に則り変更区分を選択する。

同一治験とは、主たる被験薬と同一治験成分、効能・効果（目的・デザインが同じ）、製剤・用法・投与量が同じ場合。これらに変更となる場合は、重大な変更（Substantial amendment）として、届出回数が増える。

重大な変更

該当なし

N回提出

- ・被験薬の追加（30日調査対象）
- ・対象疾患の変更
- ・治験の目的の変更
- ・治験使用薬（治験薬以外）の追加（安全性情報が不十分）

事後
6か月を目安

事後提出

- ・医療機関の代表電話番号・診療科名変更
- ・CRO・SMOの連絡先・委託範囲の更新
- ・治験責任医師・分担医師の氏名変更
- ・届出担当者の所属・連絡先変更
- ・医薬品一般名表記の改正対応
- ・輸入元業者の法人名変更（実態変わらず）

事前

事前提出

- ・実施期間の延長（観察終了日延期）
- ・治験責任医師の追加（医療機関追加に伴う）
- ・観察項目・評価指標の変更
- ・投与方法・用量の大幅な変更
- ・被験者数の大幅変更

必要な治験関連文書

治験計画届には複数の治験関連文書が必要であり、これらはPDF化し電子媒体にも格納します。



主な必要文書

必要な治験関連文書には、治験計画届書、プロトコル、治験薬概要書（IB）、説明文書と同意文書（ICF）、症例報告書（CRF）見本、科学的妥当性を説明した文書等が含まれます。これらは治験の実施に不可欠です。



PDF化と電子格納

これらの文書はすべてPDF化することが求められ、さらに電子媒体に格納します。これにより、法令に従った安全で効率的な管理が可能です。

アウトプット形式【Output】

治験届のアウトプット形式は、XMLとPDFの二種類で、規定に沿ったフォーマットで提供します。

1 XMLファイル

治験届のXMLファイルは構造化データであり、共通情報や被験薬情報などが含まれています。ファイル名や形式はPMDAのスキーマに従う必要がありますが、その多様性において詳細に整備された表示はコンプライアンスを確保します。

2 PDFファイル

PDFファイルにはICFやIBが含まれており、テキスト含有が必須です。ファイルはCD-RやDVD-Rで提出するため、事前の準備と品質チェックが不可欠です。プロトコルなどへのしおり付加が義務となっています。

アウトプット形式 – 事例 PDFファイル名

(1) PDF 形式

1) ファイル名は、半角英数字及び記号で作成し以下の形式とする。

届書の種類	届書分類		ファイル名*	ファイル名の例
治験計画届	K	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_03_K.pdf
		添付資料**	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_K_P.pdf
治験計画変更届	H	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 変更回数 .pdf	TYK-123_03_H_12.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 変更回数 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_H_12_etc.pdf
治験終了届	S	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_03_S.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_S_etc.pdf
治験中止届	C	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_03_C.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_03_C_etc.pdf
開発中止届	END	届書	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 .pdf	TYK-123_00_END.pdf
		添付資料	治験成分記号 - 届出回数 - 届書分類 - 資料情報 .pdf	TYK-123_00_END_etc.pdf

* 「治験成分記号」は主たる被験薬の治験成分記号を指す

** 非臨床安全性試験の最終報告書のファイル名は 5. 参照

全体像について

薬物の治験計画届出件数の推移

	初回 治験計画届	n回 治験計画届	治験計画変更届	治験終了届	治験中止届	開発中止届
2014年度(平成26年度)	151(20)	450(33)	4321	498	67	117
2015年度(平成27年度)	127(10)	530(45)	4566	507	70	102
2016年度(平成28年度)	134(10)	511(63)	4998	469	93	111
2017年度(平成29年度)	136(3)	557(59)	5200	456	65	100
2018年度(平成30年度)	175(11)	589(77)	5485	477	98	119
2019年度(令和元年度)	162(7)	512(65)	6063	465	86	110
2020年度(令和2年度)	186(10)	603(60)	6289	440	82	103
2021年度(令和3年度)	194(9)	614(66)	7114	525	135	122
2022年度(令和4年度)	179(5)	463(51)	6489	503	109	157
2023年度(令和5年度)	161(8)	377(32)	5660	390	108	155

(注1)

n回治験計画届は、30日調査対象外の治験計画届である。

(注2)

初回治験計画届、n回治験計画届における()の数値は、いわゆる医師主導治験に係る届出数を示す。

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0014.html>

システム開発の留意点

項目	重要ポイント
データの構造化構成	XML・PDFの出力のためのデータベース管理、UI/UXの構築も必要
ワークフロー	承認・レビュー・提出のステータス管理（ドラフト→レビュー→承認→提出済）
入力補助	入力支援（例：過去治験コピー、差分データ、辞書、バリデーション）
バージョン管理	文書改訂履歴・差し替え管理（旧版もトレース可能に）
規制対応	ER/ES指針、CSV、21 CFR Part 11、PMDA電子申請基準

リファレンス

PMDA 医薬品(薬物)の治験計画届出制度

<https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0004.html>

High-Level Key Points about CTN in Japan

- **CTN is a mandatory regulatory submission** to initiate clinical trials involving unapproved drugs or off-label uses in Japan.
- **Submitted to PMDA 30-day silent review period.**
 - No objection = trial may proceed.
 - PMDA raises any inquiry, a response is required within **21 calendar days**.
- **Only a Japan-based entity** (e.g., MAH or legal representative) can submit a CTN.
- **All documents must be in Japanese**, including PTC, IB, ICF, CMC docs and scientific docs.
- **No formal approval letter or IND number** is issued.
- **Pre-consultation with PMDA** is optional but recommended for novel trials.

High level workflow

Step	Description	Responsible Party	Key Documents / Notes
1. Protocol Finalization	Finalize protocol aligned with ICH-GCP and PMDA expectations	Sponsor / Clinical Team	English and Japanese versions
2. Preparation of CTN Package	Prepare key materials: protocol, IB, CMC data, consent forms (in Japanese), etc.	Regulatory Affairs (Japan)	Translation required
3. Pre-consultation with PMDA <i>(optional)</i>	Scientific consultation on study design, endpoints, safety, etc.	Japan Regulatory Lead	Requires scheduling (~1-2 months in advance)
4. CTN Submission	Submit CTN via PMDA Gateway (electronic submission)	Legal Representative	CTN form (XML), attachments
5. 30-Day Waiting Period	PMDA conducts a 30-day safety and quality review. No feedback = implicit approval.	PMDA	No formal approval letter
6. Start of Clinical Trial	First patient can be enrolled only after the 30-day period	Sponsor / CRO / Sites	Trial officially starts
7. Amendments (if needed)	Submit partial or entire amendment notifications	Regulatory Affairs	New CTN submission required

4. CTN Submission Process

Sub-Step	Description	Responsible Party	Notes
4-1	Finalize CTN dossier (protocol, IB, CMC, ICF, etc.)	Japan RA / Functional SMEs	Must be accurate and fully translated
4-2	Prepare XML CTN form (structured data)	Japan RA or CTN vendor	Required format for PMDA Gateway
4-3	Review and obtain legal approval	MAH or designated legal entity	Approval needed before submission
4-4	Submit CTN to PMDA Gateway	Japan RA / MAH	Submission date starts 30-day review clock

5. 30-Day Waiting Period (Regulatory Review Phase)

Sub-Step	Description	Responsible Party	Notes
5-1	Monitor 30-day regulatory review period	Japan RA / Clinical Ops	No FPI before Day 31
5-2	Respond to PMDA inquiries (if any)	Japan RA / Global SMEs	Questions rare but must be addressed quickly
5-3	Confirm trial can start	Japan RA	After Day 30 if no PMDA objections
5-4	Archive CTN package and supporting documents	Japan RA / QA	Required under GCP compliance